小児発症の高安動脈炎に合併した急性心筋梗塞の１例

－de Winter Pattern および Shark fin sign を認めた例－

◎新家 加奈子[1)]、渡邊 孝康[1)]、中山 裕介[1)]、岡本 季苗[1)]、下仮屋 雄二[1)]、杉浦 英美喜[1)]、杉本 和史[1)]
三重大学医学部附属病院[1)]

【はじめに】高安動脈炎は若年女性に好発し，大動脈およびその基幹動脈，冠動脈，肺動脈に炎症をきたす原因不明の血管炎である．小児発症例は稀とされる．今回，本疾患に罹患した 10 代男児が急性心筋梗塞を合併し，経過中の 12 誘導心電図(ECG)において de Winter Pattern および Shark fin sign を認めた稀少な症例を経験したため報告する．

【症例】10 代男児．既往歴は片頭痛．小学校で掃除後に頭痛，腹痛，胸痛を訴え意識消失し，心肺停止状態となった．救急隊到着時は死戦期呼吸，心電図は無脈性電気活動の状態であった．当院搬送後，心停止の原因として急性心筋梗塞が疑われ，緊急冠動脈造影検査(eCAG)が施行された．

【検査所見】救急外来での ECG (発症後 41 分) : 洞調律，心拍数 112bpm, de Winter Pattern を認めた．アンギオ室での ECG (発症後 82 分) : 異所性心房調律，心拍数 78bpm，Ⅰ，aVL, V4～V6 誘導で Shark fin sign を認め，心室頻拍に移行した. eCAG : 左冠動脈主幹部に血栓性完全閉塞を認め，経皮的冠動脈インターベンションが施行された．

【経過】精査で右外頚動脈閉塞および右冠動脈，左回旋枝，腹腔動脈，上腸間膜動脈，右腎動脈に狭窄が確認された．更に ^{18}F-FDG-PET/CT において病変部位に一致する集積を認めたため，高安動脈炎と診断され治療が開始された．

【考察】小児発症の急性心筋梗塞の病因として，冠動脈の先天性異常や川崎病が挙げられるが，本症例のような高安動脈炎も念頭に置く必要がある．経過中の ECG で認めた de Winter Pattern は急性前壁心筋梗塞患者の早期に認められる所見であり，左前下行枝近位部病変を示唆する．また，Shark fin sign は ST 上昇型心筋梗塞の中でも，本症例のような左冠動脈主幹部病変や左前下行枝近位部病変に関連し，重症心室不整脈と心原性ショックのリスクが高いことを示唆する稀少な所見である．これら 2 つの特徴的な心電図サインは，急性心筋梗塞の超急性期に左前下行枝近位部の亜閉塞から左冠動脈主幹部閉塞へ短時間で進展した病態を捉えたものと考える．

【結語】小児発症の高安動脈炎に急性心筋梗塞を合併し，稀少な心電図変化を捉えた症例であるため報告する．

連絡先:059-231-5244 (心電図室直通)